

**RISCOS AMBIENTAIS À CRIANÇA: -REFLEXÕES PARA A
PROPOSIÇÃO
DE INTERVENÇÃO PREVENTIVA JUNTO A FAMÍLIAS**

MARIA APARECIDA TREVISAN ZAMBERLAN¹, RENATA GROSSI,
CYNTHIA BORGES DE MOURA,
ELIAS DO CARMO LIMA, ÁUREA EMILIA, VANESSA
ALESSANDRA TOMAZ, MÁRCIO APARECIDO PINHEIRO,
GISLAINE APARECIDA DE ANDRADE E MARISTELA APARECIDA
BOLDO

Universidade Estadual de Londrina

RESUMO: Riscos ambientais físicos e psicossociais têm sido considerados como a maior causa de mortalidade e inabilidade infantis. Não obstante os altos custos sociais dessas injúrias, não tem havido um incremento proporcional de programas de natureza preventiva que objetivam a atenuação ou solução para tal questão. Neste artigo de divulgação, são discutidas conceituações, modelos e estratégias de promoção de programas preventivos a riscos na infância, como referência dentro da qual esforços devem ser feitos com o propósito de aplicação ao treino familiar, através do apoio de profissionais que atuam comunitariamente, em prevenção junto a famílias.

PALAVRAS CHAVE: Riscos, Desenvolvimento, Ambiente, Interação, Cuidados, Crianças.

¹ Endereço: Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Educação, Caixa Postal 6001, Campus Universitário, CEP: 86055-900, Londrina, Paraná.

Trabalho desenvolvido com o auxílio do CNPq em forma de Bolsa Pesquisador para Maria Aparecida T. Zamberlan e Bolsa Aperfeiçoamento para Renata Grossi, e com auxílio da CPG/Uel com bolsas de iniciação científica para os demais membros.

1 INTRODUÇÃO

O recurso de se promover estimulação essencial ao desenvolvimento, mediante a organização da experiência e de arranjos ambientais bem sucedidos é considerado bastante efetivo dada sua comprovação em vários estudos conduzidos com tal fim. Tais trabalhos apontam que, mesmo sob condições adversas de limitações genéticas, é possível alterar padrões de desenvolvimento de crianças em riscos, para o alcance de níveis superiores de desempenho visados nos propósitos educacionais, realizando-se esforços ajustados às suas necessidades fundamentais.

Pode-se constatar que um dos fatores de êxito nessa empreitada está no fato de se planejar tais experiências **em caráter preventivo**, quando crianças começam a responder, diferencialmente, à variedade e quantidade de estimulação presentes no ambiente (McPhee & Ramey apud Zamberlan, 1995)

Embora no Brasil a área de pesquisas em prevenção esteja ainda em processo inicial, e, portanto, relativamente inexplorada, já existe um acervo considerável de dados procedentes de trabalhos internacionais que comprovam a importância de se conduzir de forma adequada uma programação inicial de experiências destinada a promover mudanças no desenvolvimento, a partir de referenciais que privilegiam as interações com o ambiente.

1. 2 O Enfoque Ecológico

Nas três últimas décadas (1970 - 1990), o modo de se encarar a questão da relação organismo - ambiente indica uma nova tendência. Enquanto o modelo organísmico de explicação de causas de atrasos e deficiências perdurou, como pressuposição e norteammento de uma prática essencialmente médica, até os idos de 1960, pouco se produziu em termos de ações que pudessem favorecer o desenvolvimento de crianças com tais problemas. A situação se altera, contudo, com a assunção e adoção dos pressupostos sugeridos no modelo ecológico - que indica que o processo de desenvolvimento é resultante de complexas interações, num interjogo de variáveis ambientais consideravelmente importantes.

O reconhecimento do papel de impacto do ambiente como processo gerador de condições de estimulação que possam compensar *deficits* permitiu que se voltasse a atenção para o planejamento de programas, para a importância da mediação e da instrução na sua execução e para múltiplos componentes - de ordem sistêmica, envolvidos em tais relações.

Matos (1983) explicitou uma série de variáveis ambientais pesquisadas, indicando as maneiras pelas quais elas poderiam afetar o curso do desenvolvimento.

Embora as pesquisas conduzidas até a década de 80 indicassem resultados relativamente fragmentários da ação de variáveis isoladas sobre a questão, tal referência é extremamente útil quando se pretende identificar a concorrência, no modelo ecológico, de cada um de seus componentes.

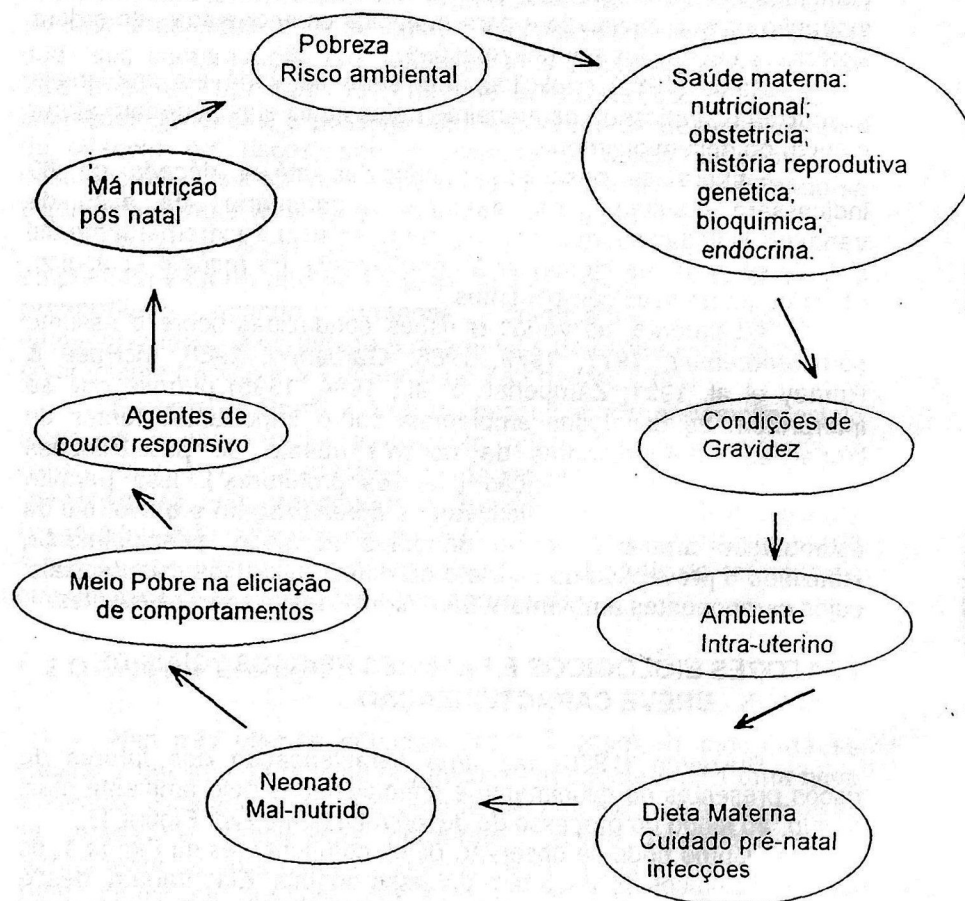
Atualmente, as várias revisões conduzidas sobre o assunto (Bronfenbrenner, 1977, 1979, 1986; Garbarino, 1988; MCPhee & Ramey et al. 1991; Zamberlan et al., 1994, 1995) permite que se interpretem as condições ambientais como importantes fontes de limitações ("determinantes de riscos") quanto de possibilidades educacionais e de prevenção ("fatores protetores"). Isso permite situar as experiências significativas de aprendizagem e o controle da estimulação ambiental como antídotos ao risco, principalmente, induzindo a prevenção da injúria e de outros distúrbios psicossociais, cujos componentes ambientais, são, na maioria, fatores relevantes.

2 FATORES BIOLÓGICOS E FATORES PSICOSSOCIAIS DE RISCOS - BREVE CARACTERIZAÇÃO

Brazelton (1986) faz uma caracterização dos fatores de riscos presentes no nascimento e condicionados pelo ambiente mais amplo, ao longo do processo de desenvolvimento (ver Figura 1).

Como pode-se observar, pelos componentes da Figura 1, os fatores biológicos de risco têm diversas origens. Elas variam, desde anomalias cromossômicas, como a da Síndrome de Down, a erros inatos do metabolismo (fenilcetonúria, por exemplo), passando por infecções viróticas (rubéola) e desnutrição da mãe até a exposição à radiação e outros produtos químicos (mercúrio, chumbo e álcool) e de fatores causais peri-natais, como: traumatismos no parto, anoxia neonatal e lesão cerebral (Krynski, 1979; Kopp & Kaler, 1989).

FIGURA 1 - Fatores condicionantes de riscos pré e pós-natais



Fonte: Brazelton, 1986

Os fatores psicossociais associados aos riscos envolvem variáveis demográficas e processuais. Dentre as variáveis demográficas, observam-se: a ocupação dos pais, o baixo nível intelectual e de escolaridade da mãe, a ordem de nascimento da criança, o tamanho da família e a organização inadequada do ambiente físico e temporal do lar. Dentre os aspectos processuais podem ser citadas variáveis relacionadas a: doença mental crônica da mãe, rigidez de atitudes, crenças e valores irracionais, ansiedade da mãe, baixa complexidade da linguagem falada, práticas educativas autoritárias, falta de suporte familiar, falta de controle dos eventos da vida por parte dos pais (locus externo de controle), eventos estressantes da vida e redução das interações afetivas positivas da mãe com a criança durante a primeira infância (Sameroff & Fiese apud Oliveira, 1993).

2.1 Discriminando os Fatores de Risco: Algumas Observações

No sentido de conduzir tanto práticas de avaliação quanto de intervenção para crianças sujeitas a riscos é necessário se fazer algumas observações quanto à conceituação e importância dos fatores co-associados na produção do risco como da ação de proteção. Dentre tais observações, consideramos as relativas a:

- a) que o conceito de risco é probabilístico, isto é, a existência de determinados atributos aumenta a chance de seu portador exibir a condição excepcional, não estabelecendo, entretanto, total e inequivocamente, o prognóstico;
- b) excetuando-se os casos extremos de disfunção biológica, é o número, mais do que a natureza dos fatores de risco, que melhor destina a condição de excepcionalidade;
- c) o peso de cada fator na instalação da condição de risco é extremamente variável, ou seja, há fatores mais ou menos fortemente associados à sua determinação;
- d) a maioria dos fatores de risco observada isoladamente não possui qualquer validade preditiva;
- e) há uma contínua interação, ao longo do tempo, entre fatores biológicos e ambientais no desenvolvimento da criança. Isto implica em que, condições ambientais tanto

podem atenuar quanto agravar os efeitos dos fatores biológicos de risco.

2. 2 Fontes de Riscos - Físicos e Psicossociais à Criança

Crianças estão sujeitas a uma série de riscos físicos desde um acidente automobilístico até eletrocução por choque. Tais situações fazem parte do cotidiano das famílias e elas atingem, variavelmente, as crianças conforme seus níveis de idade e de competência social.

A ingestão de objetos ou substâncias especiais por crianças pequenas tem recebido grande atenção nos programas de natureza preventiva. Segundo as estatísticas, a criança que se intoxicou uma vez tem mais chance de repetir o acidente, portanto, uma possível reincidência tem que ser prevenida com mais rigor.

Outras situações de risco relatadas têm sido: afogamentos, queimaduras (por alta descarga elétrica, substâncias químicas ou tóxicas), acidentes de moto ou outros esportes, com quedas, traumatismo, inabilitações, e também envenenamentos e intoxicações. A exposição à radiação é um risco que pode atingir crianças de diferentes regiões geográficas, demográficas e classes sociais. Hoje, este risco já está sendo objeto de esforços preventivos, como, por exemplo, o de retirar as crianças de zonas especiais que não ofereçam segurança, distantes do fator de radiação. Situação mais comum é a prevenção de riscos epidemiológicos, em que, grupos definidos como de "riscos" são isolados, emergencialmente, para evitar contaminação por moléstias, em circunstâncias especiais, à exemplo de terremotos e outros acidentes catastróficos os quais probabilizam o surgimento de infecções.

As condições de riscos físicos no ambiente envolvem desde: cercas pontiagudas, objetos cortantes, escarpas montanhosas para escalar, ondas perigosas do rio/mar, produtos inflamáveis, cosméticos, cigarros, fósforos, gases poluentes, produtos tóxicos, fios de alta tensão.

Atitudes de prevenção ao risco devem considerar tanto a **vulnerabilidade individual** ao mesmo quanto as **condições ambientais objetivas** que podem desencadear o dano. A vulnerabilidade individual está relacionada ao *status* de desenvolvimento da criança (sua idade/experiência/condições de

enfrentamento) e as condições sócio-ambientais dependem de fatores culturais, como a impunidade/falta de responsabilidade legal pelo dano.

Crianças (especialmente pré-escolares) têm sido alvos preferidos de riscos. Uma prática preventiva de cuidado deve ser a de propiciar supervisão e proteção adulta às suas atividades, impedindo que se tornem mais vulneráveis. Uma de tais estratégias minimizadoras da ocorrência do risco é a de se proporcionar, próximo a ambientes escolares infantis, a inspeção da aproximação de estranhos às crianças; orientando para que não falem nem dirijam-se a eles para passeio - à pé ou de carro - e nem que recebam presentes ou incentivos.

Isto significa que a estratégia mais eficaz de controle, aqui, estaria mais nas ações da própria criança no sentido de evitar, precipitar ou produzir eventos desencadeadores do risco.

Outra fonte importante de risco à criança, diz respeito às pessoas que convivem com elas (Garbarino, 1988; Santos, 1990). Mensagens televisivas noticiam o perigo de rapto de crianças pequenas por estranhos, as quais são vendidas a estrangeiros ou custodiadas institucionalmente, até que se regularizem suas situações de adoção. Para a incidência dessa ocorrência, os esforços preventivos na área ainda são totalmente inexistentes.

É também cada vez maior o risco à criança de tutela por pais negligentes, que não oferecem qualquer apoio e orientação aos filhos ou quando não, os exploram ou os sujeitam a abusos e maus tratos de natureza física e sexual. Agressões, estupro e assaltos por pessoas familiares têm sido alvos de atenção no Brasil (dados do IBGE, 1988, 1992; IPEA, 1990). Babás, vizinhos, outros membros da localidade e até professores são mais sujeitos de suspeição, hoje, com referência a ataques, injúrias e violências induzidas contra crianças (pedofilia/violência sexual) e, estatisticamente, essas ocorrências estão quase nos mesmos índices que as ameaças e ataques produzidos dentro da própria família.

A taxa de risco per capita, nesta situação, atinge mais a uma população específica, ou seja, filhos de pais separados, mãe-solteira, ambientes promíscuos, onde, também, a incidência de ataques por pessoas da família é maior.

Prevalentemente, as injúrias acidentais atingem hoje, cerca de 46,55% de todas as mortes de crianças de 1 a 4 anos de idade e

cerca de 55% das crianças de 5 a 14 anos. Nessa faixa, acidentes por veículos, água e fogo, bem como ataques e negligências parentais têm sido os principais (10% a 14%) a afetar crianças (incluindo situação de seqüestro, para a qual ainda não se dispõem de mecanismos preventivos e de orientação adequados). Segundo estatísticas oficiais nos Estados Unidos, tais injúrias são responsáveis por mais da metade das mortes de crianças entre as idades de 1 a 14 anos (Margolis & Runyan apud Frank, Bouman, Cain & Watts, 1992). Tanto em famílias de baixa como de alta renda há falta de tais orientações, necessitando mais campanhas para informar seus agentes de cuidados.

Certamente, um conjunto coordenado de ações preventivas responderá pela diminuição da probabilidade de riscos. No ambiente da escola, por exemplo, há, ainda, muitas brechas na cobertura de ações de orientação e supervisão; outro contexto é o social, na situação em que a criança esteja lanchando só ou com outras, em um *shopping center*, por exemplo.

Nesse sentido, é que tais riscos devem fazer parte de um programa ecológico geral. Tais políticas exigem compromissos sociais intensivos de todas as agências públicas federais e locais; privadas e voluntárias.

2.3 O Que os Novos Modelos da Psicologia Ecológica e Ambiental Ugerem à Prevenção de Riscos

Estabelecendo que a origem da maior parte desses riscos esteja no contexto social, Stokols (1992) propõe uma perspectiva ecológica sobre a questão da prevenção no desenvolvimento humano, a qual o situa como um processo ativo, intencional e adaptativo do organismo na interação com o seu meio, que constitui-se num sistema social, onde forças de natureza sócio-econômicas, sociológicas, psicológicas e biológicas estão envolvidas na produção da qualidade de vida.

Stokols (1992) associa essa perspectiva (social ecológica) à promoção de bem estar e saúde, onde vários sub-sistemas interagem (constantemente em processos de retro-alimentação). Através das ações de agentes ou situações sociais e ambientais ocorrem multi-influências no desenvolvimento.

Nesse sentido, o autor propõe que a abordagem considerada deva orientar as políticas sociais dos programas preventivos de danos à criança, numa visão global, isto é, dirija-se a múltiplos agentes; abranja uma ampla fonte de riscos e proponha várias e possíveis combinações de ações para prevenir riscos, definir responsabilidades e testar metodologias.

O Quadro 1 focaliza algumas das dimensões de recursos ambientais, para garantir níveis de saúde populacional e de seus resultados: psicológicos, fisiológicos e comportamentais, segundo Stokols (1992).

GARBARINO (1988) sugeriu um modelo de prevenção, abrangendo como referência:

- a) as fontes de risco ambiental à criança;
- b) os alvos da intervenção preventiva e
- c) as estratégias de alocação e implementação de recursos para promover a prevenção.

No modelo sugerido, as três classes de alvos da intervenção preventiva são:

- a) a criança;
- b) o agente de cuidados, e
- c) a sociedade (Roberts et al. apud Garbarino, 1988, p.33).

QUADRO 1 - Algumas dimensões ambientais e critérios promotores de saúde e seus possíveis resultados

Faces da Saúde	Recursos Ambientais	Resultados psicológicos, fisiológicos e comportamentais
Saúde Física	modelo resistente à injúria, modelo ergonômico; ambientes de conforto físico, não tóxicos e não patogênicos.	Saúde fisiológica; falta de sintomas de doença e injúria; conforto; saúde reprodutiva e genética.
Bem-estar Emocional e Mental	controlabilidade e predizibilidade ambiental; desafio e novidade ambiental; baixa distração; qualidades estéticas; elementos simbólicos e espirituais.	Senso de competência pessoal, desafio e desempenho; crescimento; experiência mínima de stress emocional; sentimento forte de identidade pessoal e criatividade; sentimentos de ligação ao meio físico e social.
Coesão Social nos níveis organizacionais e comunitários	disponibilidade de redes de suporte social; processos de planejamento e administração participativos; flexibilidade organizacional e responsividade; estabilidade econômica; baixo potencial para conflito intergrupai; mídia e programas promotores de saúde	Níveis altos de contato social e cooperação; satisfação e compromisso com a organização e a comunidade; produtividade e inovação nos níveis organizacionais e comunitários; altos níveis de qualidade de vida; prevalência da promoção de saúde, da prevenção contra injúria e comportamento ambientalmente protegido.

Fonte: Stokols (1992)

QUADRO 2 - Uma Referência para Classificar Dimensões de Risco Infantil com Finalidade de Intervenção Preventiva

1. Fontes de Risco à Criança a) Acidentes e perigos b) Ambiente não estimulador c) Maus tratos parentais d) Ataques e assaltos e) Agressões e violência sexual
2. Alvos da Intervenção Preventiva a) A Comunidade b) Os agentes de cuidados c) As próprias crianças
3. Meios/ recursos para promover Prevenção a) Legislação/ regulamentação b) Campanhas Educativas em Meios Maciços de Comunicação c) Treino Individual d) Instruções Grupais a grupos especiais(de risco) e) Organização e Divulgação de Material Impresso

Fonte: Garbarino, J. (1988, p. 28).

2.4 Alvos da Intervenção Preventiva

Programas preventivos podem ter como alvo a criança ou o adolescente, diretamente, endereçando-lhe uma ampla variedade de orientações, como: não ingerir líquidos desconhecidos; como evitar estranhos; como atravessar ruas ou como dirigir com responsabilidade. Especialmente na área de tráfego, crianças - como pedestres - e jovens - como motociclistas - têm sido sujeitos a riscos fatais. Ensinar habilidades emergências a eles tem sido premente.

O pressuposto da prevenção, tendo por alvo a criança, é o de que ela poderá ser ensinada e deverá se tornar capaz de desempenhar um novo comportamento o qual deverá demonstrar ser apropriado para um especial contexto. Em nível de uma criança pré-escolar pode se esperar alguma concordância em seguir as

orientações antes que capacite-se para avaliar os graus de risco e as medidas objetivas de preveni-los. Uma estratégia é a de que a família, também envolvida nesses programas, encorage e fortaleça esse comportamento como esforço conjunto para se alcançar sucesso.

Os programas endereçados aos agentes de cuidados devem procurar reduzir as fontes de riscos acidentais, como: exigir um mínimo de idade e maturidade para a escolha da babá; re-orientar práticas disciplinares junto à criança; reconhecer e identificar indicadores de riscos e disciplinar a presença de objetos perigosos no ambiente.

A comunidade pode ser alvo de programas preventivos através de intervenções legais (na elaboração de códigos de defesa do consumidor; recomendações sobre bulas e usos de produtos; monitoramento de atividades profissionais e educacionais; campanhas de esclarecimentos aos cidadãos acerca de usos de técnicas e métodos de prevenção à saúde e cuidados/defesa pessoal). Iniciativas comunitárias, são, portanto, meios muito importantes no sentido de atingir grandes contingentes de pessoas. Tais meios são considerados medidas passivas e indiretas quando comparados aos trabalhos diretamente propostos à criança ou junto aos agentes de cuidados.

Estratégias referentes aos alvos da intervenção dizem respeito, ainda, à efetividade da condução de tais programas direta ou indiretamente.

2.5 Estratégias Metodológicas dos Programas de Intervenção Preventiva

2.5.1 Treino individualizado às crianças e aos agentes de cuidados

Programas comunitários necessitam de um crescimento de impacto em abordagens centradas diretamente nas pessoas. Embora as pesquisas tenham revelado demonstração de maior capacidade de reduzir riscos quando envolvido o nível motivacional das pessoas, diretamente, tais programas são difíceis de se viabilizar, dentro do contexto social realístico em que vivemos, principalmente se desejarmos atingir um grande contingente de beneficiários.

Treino individualizado sempre se contrapõe a soluções de impacto e massivas. Para que um programa possa ter a mínima efetividade de alcance é importante que vários grupos sejam beneficiados. Programas desenvolvidos por vários tipos de profissionais e para-profissionais (sanitaristas, enfermeiros, professores, visitantes familiares) em geral, visam atingir um número razoável de beneficiários (Pettersson & Mori apud Garbarino, 1988).

2.5.2 Treino em grupos

Face à extensão de riscos ambientais e aos altos custos de treinos intensivos individualizados, tem - se optado por treinos oferecidos em grupos. Treinos em pequenos grupos envolvem outro nível de recrutamento e de manutenção.

Alguns programas com crianças demonstram a capacidade de ensiná-las a evitar acidentes com fogo, a fazer algumas alterações no ambiente (recolher o lixo e separá-lo para reciclagem) e a agirem cooperativamente umas com as outras, como se fossem vítimas potenciais.

2.5.3 Materiais instrucionais

Os materiais educativos programados, por outro lado, são meios que têm proliferado e eles atendem a programas específicos de prevenção, como os de abuso sexual e de prevenção contra assaltos. As dimensões comerciais e demandas políticas desses meios tomam tais materiais nos mais importantes veículos para desenvolver programas de mudanças. Contudo, uma avaliação e controle da qualidade desses materiais se fazem necessárias. Poucos materiais e programas têm sido avaliados e isso diz respeito tanto a catálogos, folhetos ou manuais especializados. Há também a dificuldade de recepção, quando materiais impressos se destinam a uma população analfabeta ou pouco informada. A avaliação formal, mesmo de um programa planejado para prevenção na área de saúde (Gallagher apud Eisenstein, 1993) nem sempre é feita e o engajamento em políticas de prevenção exige esforços para estimar seus impactos entre as comunidades envolvidas, demandando controle do material veiculado.

2.5.4 Campanhas através de meios de comunicação de massa

Especialistas em prevenção têm explorado o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de promover e realizar campanhas, como: prevenção de doenças do coração, moléstias infecto-contagiosas, etc. às quais visam conscientizar, fortalecer ações individuais e criar um clima de legitimidade para a adoção das políticas e comportamentos - padrões desejáveis. Contudo, o conteúdo ingênuo e apelativo de muitas campanhas é, muitas vezes, responsável pelo contra-controle e não adoção de tais práticas, por algumas pessoas a que se destinam, mesmo que consideradas solução de valor em prevenção.

2.5.5 Legislação / regulamentação

Líderes comunitários, profissionais e voluntários têm desenvolvido programas individualizados de grande impacto e apelo. Especialistas têm discutido isso, face à propriedade da legislação para tratar de questões, envolvendo autoridade e ética, com referência à prevenção de injúrias. Dentre tais aspectos, têm sido ressaltado o valor de implementar:

- a) medidas políticas e econômicas para que se desenvolvam padrões aceitáveis de proteção à infância, nos campos da segurança e bem estar;
- b) medidas de impacto de forma a garantir níveis toleráveis de toxidade do ambiente;
- c) explorar, com argumentos convincentes, as fontes de riscos e conseqüências a si mesmos e a suas vítimas, a motoristas adolescentes que pleiteiam antecipação de carteira de habilitação para dirigir;
- d) exame de impedimentos legais (alteráveis culturalmente) com referência a aborto em condições de risco para a mãe e a criança. Programas vastos de informação e empenho comunitários são formas de orientação que podem minimizar o peso da custódia de crianças em condições críticas;
- e) esclarecimento do conceito "nível aceitável de riscos" que, às vezes, se impõem às crianças como um tipo de

estimulação da exploração em favorecimento do seu desenvolvimento cognitivo, por exemplo, a exposição de crianças em playgrounds cimentados, com escorregadores e balanços, que podem se constituir em fator de risco;

- f) outro aspecto a considerar é o de provisão de fundos e outras providências de ordem físico-financeira que poderão ser tomadas para custeio de projetos de pesquisa e intervenção na área; ampliação de recursos para capacitação e treinamento de pessoal técnico habilitado; construção de centros e unidades especiais de atendimento; criação de instâncias gerenciadoras desses recursos, funcionando para ajudar a cumprir os direitos dos beneficiários, em relação aos deveres com eles assumidos.

3 REFLEXÕES PARA A PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÃO PREVENTIVA JUNTO FAMÍLIAS

3.1 Aspectos Gerais de Educação Preventiva

A intervenção psico-educacional ao âmbito da família visa prover uma sistemática organizada de cuidados à criança, oferecer informações adequadas para monitorar seu desenvolvimento físico e psicossocial e subsidiar ações para organizar o contexto sócio-ambiental e familiar.

Mais importante que os sintomas, segundo os pediatras, é a história e os detalhes do acidente. O problema é que, em muitos casos, os pais não sabem informar, porque não estavam com a criança no momento da sua ocorrência.

Acontece que, na maioria das vezes, os pais trabalham fora e deixam os filhos com outras pessoas ou até sozinhos em casa. Quando têm condições, as opções de cuidados por outro agente se resumem à empregada, berçário, creche ou parentes.

Como já foi dito, uma das formas de evitar acidentes é ensinar ao filho como evitá-los, mas isso exige a adaptação do aprendizado às suas possibilidades de compreensão, de amadurecimento, de habilidades motoras, lembrando-se ainda, de que não se trata de assustá-lo mas sim de instruí-lo. É um aprendizado demorado, que precisará de supervisão atenta até a

aquisição perfeita da habilidade ser alcançada, ou seja, até a criança dar mostras de "responsabilidade".

3.2 Objetivos da Intervenção PSICO-EDUCACIONAL

A intervenção psico-educacional visa atingir parcelas amplas da população, através de várias ações, principalmente de natureza preventiva, a saber:

- a) propor programas de intervenção familiar, que objetivem auxiliar os pais em cuidados gerais à criança;
- b) traduzir/ilustrar as orientações de cuidados e informações técnicas sobre cuidados e estimulação ao nível de populações que apresentem baixo nível de escolaridade (fornecer conhecimentos, atendendo as suas necessidades e respeitando seu universo cultural);
- c) Orientar famílias quanto aos seus direitos de cidadania e de beneficiárias de recursos públicos para melhor promover o desenvolvimento de seus filhos.

3.3 Sugestão de uma Programação de Intervenção

3.3.1 Instruções iniciais

Aqui estão descritas e exemplificadas algumas situações de perigo mais comuns às crianças em desenvolvimento - 0 a 6 anos. Leve-as em consideração e tome as devidas providências.

A primeira providência é a de ter sempre à mão um número de telefone para emergência. Quando sair, deve-se deixar avisado, a quem ficar com a criança, onde você estará e como poderá avisá-la, no caso de algum problema.

3.3.2 Sugestões para condução de sessões - temas sobre riscos e cuidados

- a) Levantamento de aspectos da realidade da família dentro do assunto a ser discutido e exposição com cartazes e oral.
- b) Relacionar os aspectos abordados no início da intervenção com o assunto exposto.

- c) Fazer um fechamento com a família de quais os riscos presentes no ambiente e procurar soluções para cuidados.
Riscos: - quais são os possíveis riscos presentes no dia a dia da criança e de toda a família?
Cuidados: - quais são os possíveis cuidados para tais riscos?
- d) Elaborar frases de fechamento do assunto.

3.3.3 Tópicos relativos a riscos ambientais físicos

3.3.3.1 Medicamentos

Reuna todos os medicamentos da casa num único local, fora do alcance das crianças e discipline-se (e aos outros membros da família) para nunca deixá-los acessíveis, ao acaso, sobre os móveis ou outros locais. Jogue fora restos de remédios. Não os transfira de embalagem.

Cuidado ao dar remédio à criança; observe a data de validade, a quantidade e se não está dando algo que não seja o recomendado para ela.

3.3.3.2 Produtos de limpeza

Reuna também todos os produtos de limpeza num armário que permaneça sempre fechado. Instrua as outras pessoas da casa a fazer o mesmo. Produtos tóxicos- como: cosméticos, bebidas alcoólicas, tintas, graxa de sapato, inseticidas, enfim, também devem ficar bem guardados, longe do alcance das crianças.

Se a criança for intoxicada, procure um médico imediatamente, e leve junto o produto ingerido para facilitar a identificação do antídoto. Lembre-se que os minutos podem ser preciosos para salvar a vida da criança.

3.3.3.3 Matagais

Lembre-se que os insetos se reproduzem nos matagais e isso pode ser prejudicial à saúde da criança e da família, além do que

existem plantas venenosas que podem ser ingeridas pela criança, por isso remova estas plantas e os matagais.

3.3.3.4 Fogão/fogo

Cuidado com os fogões; as crianças podem girar os botões do gás e envenenarem-se, por isso mantenha a chave-geral desligada. As crianças mais velhas podem querer subir no fogão ou puxar uma panela e acabar se queimando. Fogões e fósforos chamam a atenção de crianças, mas CUIDADO - quando novas, afaste-as disto e, quando mais velhas oriente-as de como usar.

3.3.3.5.Ferro de passar

O ferro de passar roupas deve ficar longe do alcance das crianças muito pequenas e as maiores devem ser orientadas quanto ao seu uso, caso contrário, podem se queimar.

3.3.3.6 Lixo

A lata de lixo deve ter tampa pesada e/ou ser posta em local inacessível à criança. Não acumule lixo e entulhos dentro de casa ou no quintal; isto é prejudicial à saúde da família, pois favorece a reprodução de insetos e vermes.

3.3.3.7 Ferramentas

Mantenha suas ferramentas, facas e tesouras bem guardadas, também em local inacessível. As crianças mais velhas devem ser ensinadas a manusear e utilizá-las corretamente; no início, sempre em companhia de um adulto. Ensine-as, também, onde e como guardá-las.

3.3.3.8 Cantos/degraus

As crianças, de modo geral, não se atêm a cantos de móveis e degraus. Quando pequenas, afaste os móveis para que a criança se movimente, sem muita preocupação, e quando forem crescendo, vá ensinando como se desviar dos cantos e pontas. Quanto aos

degraus, desde cedo procure ensinar seu filho a descê-los e a subi-los.

3.3.3.9 Lugares altos/escorregadios/tomadas/fios/arames/latas/pregos

As crianças não têm muita noção de perigo, por isso tome cuidado com lugares altos, escorregadios, com tomadas, fios, arames, latas e pregos. Quando muito pequenas, afaste-as destes perigos; quando maiores, oriente-as quanto a eles e como fazer para não se machucarem. As latas, arames e pregos quando enferrujados podem transmitir o tétano. Assim, se a criança se machucar com uma dessas coisas, procure um posto de saúde, ela precisará ser medicada.

3.3.3.10 Automóvel

O automóvel faz parte da vida moderna e é impossível evitá-lo. É grande o número de acidentes fatais com crianças, em grande parte porque os pais não tomam as devidas medidas de segurança ao transportarem seus filhos nos carros.

Os cintos de segurança não se adaptam a crianças pequenas e por isso outras medidas se fazem necessárias. O uso de assentos especiais para crianças, adaptados ao assento traseiro do carro e bem seguros pelo cinto, pode resolver o problema até que a criança tenha tamanho suficiente para servir-se dos cintos comuns.

As crianças devem viajar sempre no banco traseiro. As portas devem estar travadas e os vidros levantados. Nunca deixe crianças sozinhas no carro estacionado.

3.3.3.11 Água

As crianças adoram banhar-se e brincar com água e não devem ser privadas disto. A preocupação é tê-las sempre acompanhadas por um adulto atento. Mesmo em águas rasas, que não parecem oferecer nenhum perigo, acontecem acidentes fatais. Ao se ver com o rosto submerso, a criança tentará gritar e respirar, introduzindo água nos pulmões e afogando-se rapidamente. A advertência vale tanto para o mar quanto para lagoas, tanques,

bacias, piscinas, banheiras, enfim., todo tipo de local onde existe água acumulada.

Ensine seu filho a nadar, logo que possível. Mesmo depois do aprendizado não o deixe sozinho. Outro cuidado que se deve ter é com as águas contaminadas; não deixe a criança se banhar em águas que possam estar contaminadas.

3.3.3.12 Pequenos objetos

Crianças menores, abaixo de cinco anos, gostam de levar constantemente objetos à boca. Chaves, moedas, grampos, parafusos, botões, cliques e grãos podem ser engolidos, facilmente. Muitas vezes, a criança não se queixa e a mãe não percebe.

3.3.3.13 Quedas

Não deixe crianças pequenas em cama sem proteção. Quando estiver em apartamentos, ou lugares altos, tomar cuidado com a altura dos ambientes. Os móveis, como: poltronas e sofás, ou mesmo cadeiras não devem estar próximos às janelas ou sacadas.

3.3.3.14 Armas

Armas de fogo devem ser guardadas em local seguro e de preferência, descarregadas. É importante mostrar às crianças os seus riscos.

ABSTRACT: Physical and Psychosocial Environment risks have been considered as the greatest causes of deaths and disability among children at ages between one to six. Despite the increasing number of children being victimized and surveys showing that exposure to risk is high for many children, there hasn't been a growth in the amount of preventive programs addressed to reduce or/and solve the problem. This article focuses on

the revisited basic knowledge in the area, discusses concepts, methodological issues, models and strategies to promote preventive programs for infants subject to risk. It aims at developing a framework in which related efforts will be made in search for alternative applications to family training (parental involvement), with a specific focus on interactions community-homes, with support of professionals.

KEY-WORDS: Risks, Development, Environment, Interaction, Care, Childrens.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- EISENSTEIN, E., PAGONCELLI, J. *Situações de riscos à saúde de crianças e adolescentes*. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.
- FRANK, R.G., BOUMAN, D.E., CAIN, K., WATTS, C. Primary prevention of catastrophic injury. *American Psychologist*, v.47, n.8, p. 1045-1049, aug. 1992.
- GARBARINO, J. Preventing childhood injury: developmental and mental health issues. *American Journal of Orthopsychiatry*, New York, v. 58, n. 1, p. 25-45, jan. 1988.
- IPLAN. IPEA. *A Criança no Brasil: o que Fazer?* Brasília: Ministério do Planejamento /UNICEF, 1990.
- HOROWITZ, F.D. Methods of assessment for high risk and handicapped infants. In: RAMEY, C., TROHANIS, P. (Ed.). *Finding and education on the high-risk infant*, New York: McGraw-Hill, 1978. Cap.7.
- HOROWITZ, F.D. *Intervention and its effects on early development. What model of development is appropriate? Life-span development Psychology-Intervention*. New York: Academic Press, 1980. Cap. 11, p. 235-248.
- HOROWITZ, F.D. Comunicação apresentada no curso modelos de desenvolvimento e intervenção. In: REUNIÃO ANUAL DE

- PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 22., 1992, Ribeirão Preto. *Anais...* Ribeirão Preto: New Impress, 1992.
- KOPP, C.B., KALER, S.R. Risk in infancy: origins and implications. *American Psychologist*, v.44., n.2, p. 224-230, feb. 1989.
- LAMPREIA, C. A prevenção no atraso do desenvolvimento. *Psicologia: Ciência e Profissão*, Brasília, v.5, n.1, p. 25-30, 1985.
- LÉFÈVRE, B.H. *Mongolismo*. São Paulo: Sarvier, 1981.
- MARINHO, H. Estimulação essencial. *Pesquisa*, SBP-CENESP/MEC, 1977.
- OLIVEIRA, L.R.N. DE Prevenção da excepcionalidade em creche. In: CICLO DE DEBATES SOBRE O EXCEPCIONAL, 1993, São Carlos. *Boletim...*, São Carlos, 1993.
- PETERSON, L., ROBERTS, M.C. Complacency, misdirection and effective prevention of children's injuries. *American Psychologist*, v. 47, n.8, p. 1040-1044, aug. 1992.
- SANTOS, H.O. *Crianças acidentadas*. Campinas: Papirus, 1988.
- SANTOS, H.O. *Crianças espancadas*. Campinas: Papirus, 1990.
- SINCA - IBGE. *Crianças e adolescentes no Brasil: dados estatísticos*. Rio de Janeiro, 1992.
- STELDMAN, D.J. Important considerations in the review and evaluations of educational intervention programs. *Research to Practice in Mental Retardation*, v.1, 1977.
- STOKOLS, D. Establishing and maintaining healthy environments: toward a social ecology of health promotion. *American Psychologist*, v.47, n.1, p. 6-22, jan. 1992.
- ROGERS-WARREN, A. K. Behavioral ecology in classrooms for young and handicapped children. *Topics in Early Childhood Special Education*, v. 2, n.1, p. 21-32, 1982.
- WILLIAMS, L.C.A. Intervenção precoce na excepcionalidade. *Cadernos de Análise do Comportamento*, São Paulo, v. 6, p. 38-51, 1984.
- WILLIAMS, L. C. A. *Favorecendo o desenvolvimento de crianças excepcionais em fase pré-escolar através de treino dado a seus familiares no ambiente natural*. São Paulo, 1983. Tese (Doutorado em Psicologia) - Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo.

- ZAMBERLAN, M. A. T. et al. Intervenção Psico-educacional para Crianças em Situação de Riscos. Projeto de Pesquisa 276.197/93, UEL/CNPq, 1995.